

CIÊNCIA QUE ESCUTA, SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM



Procedimento de Governança em Saúde Mental Corporativa

Diretriz para estruturação, responsabilidades e prestação de contas ao Conselho de Administração.

NR-1 · PGR/GRO

ISO 45003

VERSÃO 2.0

EMPRESA	[Razão social da empresa]
ELABORADO POR	Escutaris — Saúde Mental Ocupacional
VERSÃO	2.0
DATA DE EMISSÃO	[dd/mm/aaaa]
PRÓXIMA REVISÃO	[dd/mm/aaaa] — revisão anual
CLASSIFICAÇÃO	Uso interno — Conselho de Administração e Diretoria Executiva
APROVAÇÃO	Conselho de Administração

01 Sumário executivo

A saúde mental deixou de ser uma pauta exclusivamente assistencial ou uma resposta pontual a casos de adoecimento para se tornar um tema de estratégia, governança e gestão de riscos corporativos.

15%

dos adultos em idade produtiva convivem com um transtorno mental.

12 bi

de dias de trabalho perdidos por ano em decorrência de depressão e ansiedade.

US\$ 1 tri

de custo global anual, sobretudo por perda de produtividade.

No Brasil, a **NR-1** passou a exigir a inclusão dos riscos psicossociais ocupacionais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), tornando o tema também uma obrigação legal e um item de conformidade a ser monitorado pelo Conselho de Administração — e não apenas uma iniciativa de bem-estar conduzida isoladamente pelo Departamento Pessoal ou pela área médica.

Este procedimento estabelece a estrutura de governança, os papéis, as responsabilidades, os princípios norteadores, o modelo de atuação, as frentes de capacitação, cuidado e proteção de grupos vulnerabilizados, o ciclo de gestão de riscos e os mecanismos de monitoramento e prestação de contas necessários para que a saúde mental corporativa seja tratada com o mesmo rigor aplicado a outros riscos relevantes do negócio.

02 Objetivo

Estabelecer a estrutura de governança, os papéis e responsabilidades, os princípios norteadores, o modelo de atuação e os mecanismos de monitoramento e prestação de contas necessários para a gestão da saúde mental corporativa e dos riscos psicossociais, assegurando que o tema seja tratado como parte da estratégia, da governança e da gestão de riscos da organização, e não apenas como uma iniciativa assistencial isolada.

03 Escopo de aplicação

- Aplica-se a todos os níveis hierárquicos da organização, da alta liderança às equipes operacionais.
- Abrange empregados diretos, terceirizados, temporários e demais formas de contratação presentes na organização.
- Integra-se ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) previstos na NR-1.
- Articula-se com as políticas de compliance, código de conduta, canais de denúncia, diversidade e inclusão, e demais sistemas de gestão já existentes.
- Não substitui o atendimento médico, psicológico ou psiquiátrico individual, tampouco define diagnóstico clínico de trabalhadores.

04 Base legal e referencial técnico

- **NR-1** (Ministério do Trabalho e Emprego) — inclusão dos riscos psicossociais ocupacionais no PGR/GRO.

- **ISO 45003:2021** — gestão da segurança e saúde psicológica no trabalho.
- Convenções da **OIT** nº 155 e nº 187, sobre segurança e saúde no trabalho, e nº 190, sobre violência e assédio no mundo do trabalho.
- Diretrizes da **OMS** sobre saúde mental no trabalho (2022) e Policy Brief OMS/OIT *Mental Health at Work* (2022).
- Guia *Saúde Mental e Futuro do Trabalho*, do Movimento Mente em Foco.
- Princípios de governança corporativa do **IBGC**.

05 Princípios de governança aplicados à saúde mental

O IBGC define governança corporativa como o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as relações entre sócios, Conselho de Administração, Diretoria, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas. Aplicados à saúde mental corporativa, os quatro princípios assumem o seguinte significado prático:

Transparência

Disponibilizar informações claras sobre riscos psicossociais identificados, ações em curso, indicadores e resultados — para o Conselho, gestores e trabalhadores, para além dos aspectos financeiros do tema.

Equidade

Assegurar tratamento justo e isonômico na identificação, prevenção e resposta aos riscos, reconhecendo que riscos e recursos de proteção não se distribuem de forma homogênea entre grupos, funções, vínculos e territórios.

Prestação de contas

Reportar de forma clara, concisa e tempestiva ao Conselho os indicadores, riscos, ações e resultados, assumindo responsabilidade pelas decisões tomadas e pelas consequências da inação.

Responsabilidade corporativa

Zelar pela saúde mental como parte do capital humano, social e reputacional da organização, considerando impactos de curto, médio e longo prazo sobre a sustentabilidade do negócio.

06 Estrutura de governança e responsabilidades

A gestão da saúde mental corporativa requer papéis e responsabilidades claramente definidos e distribuídos entre diferentes instâncias, evitando que o tema seja delegado exclusivamente ao RH, à área médica ou à SST.

INSTÂNCIA	PAPEL PRINCIPAL	PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Conselho de Administração	Supervisão estratégica	Aprovar a política e o orçamento; acompanhar indicadores; garantir que o tema permaneça na agenda estratégica e de sustentabilidade.
Diretoria Executiva	Patrocínio executivo	Nomear responsável executivo (focal point); alocar recursos; comunicar o compromisso institucional.
Comitê de Saúde Mental e Riscos Psicossociais	Coordenação tática	Consolidar diagnósticos, priorizar ações, acompanhar indicadores e reportar ao Conselho e à Diretoria.
Recursos Humanos	Execução e articulação	Operacionalizar políticas, treinamentos, canais de escuta e programas de apoio.
SESMT / SST	Gestão técnica de riscos	Integrar os riscos psicossociais ao PGR/GRO; conduzir avaliações periódicas.
CIPA (quando existente)	Elo entre trabalhadores e gestão de SST	Contribuir para a identificação de riscos psicossociais no mapa de riscos, apoiar campanhas internas de prevenção e servir como canal adicional de escuta.
Lideranças (gestores)	Gestão cotidiana	Reconhecer sinais precoces, conduzir conversas sensíveis, encaminhar casos, gerir cargas e conflitos.
Trabalhadores e representantes	Participação	Contribuir com a identificação de riscos, participar de consultas e utilizar os canais disponíveis.

RECOMENDAÇÃO

Constituir um **Comitê de Saúde Mental e Riscos Psicossociais** de caráter multidisciplinar (RH, SST, Jurídico, Compliance e, quando pertinente, representantes dos trabalhadores), com reuniões trimestrais e reporte semestral ao Conselho de Administração.

Onde existir CIPA, sua atuação deve ser articulada com a do Comitê, especialmente na identificação de riscos psicossociais no mapa de riscos e na condução de campanhas internas de prevenção, sem prejuízo das demais atribuições legais da comissão.

07 Modelo de atuação: prevenir, proteger e promover, apoiar

O modelo segue as três estratégias recomendadas pelas diretrizes conjuntas da OMS e da OIT (2022). Cada estratégia tem valor limitado quando implementada isoladamente; o resultado é mais consistente quando as três são conduzidas de forma integrada.

1 Prevenir

Identificar e controlar os fatores organizacionais que geram risco — conteúdo e ritmo de trabalho, autonomia, ambiente, cultura, relações interpessoais, papel na organização, carreira e relação trabalho–vida pessoal —, priorizando a prevenção primária. Exemplos: redimensionar equipes, revisar metas e prazos, ampliar pausas, eliminar práticas abusivas, aumentar autonomia e clarificar papéis.

2 Proteger e promover

Fortalecer competências e ampliar o reconhecimento precoce de sinais de sofrimento, por meio da capacitação de lideranças, da literacia em saúde mental e de intervenções individuais de apoio. Essas ações complementam, mas não substituem, as intervenções sobre a organização do trabalho. Detalhes na Seção 08.

3 Apoiar

Garantir que trabalhadores com condições de saúde mental possam acessar, manter e prosperar no trabalho, por meio de adaptações razoáveis, programas de retorno ao trabalho e emprego apoiado, preservando a confidencialidade e evitando estigmatização. Detalhes na Seção 11.

08 Treinamentos e capacitação

A capacitação de lideranças e trabalhadores é uma das frentes mais efetivas de proteção e promoção da saúde mental no trabalho, com evidências de melhora nas atitudes e no comportamento de busca de ajuda.

LIMITE DO ESCOPO

A capacitação não transforma gestores em profissionais de saúde mental. Após o treinamento, gestores não devem diagnosticar nem tratar transtornos mentais – devem reconhecer sinais e encaminhar adequadamente.

Capacitação de lideranças

Reconhecer sinais precoces de sofrimento, conduzir conversas sensíveis, encaminhar situações de saúde, gerir conflitos, distribuir demandas de forma equilibrada, comunicar mudanças, reconhecer entregas, promover autonomia, prevenir assédio e violência e favorecer a segurança psicológica das equipes.

Capacitação de trabalhadores – literacia em saúde mental

Melhorar o entendimento sobre saúde mental e bem-estar no trabalho, reduzir atitudes estigmatizantes e estimular a busca precoce por ajuda. A participação de pessoas com experiência vivida como cofacilitadoras é particularmente eficaz na redução do estigma.

Intervenções individuais de apoio

Psicoeducação, manejo de estresse e ferramentas digitais de autoajuda. Devem ser oferecidas sempre como complemento — nunca como substituto — das intervenções sobre a organização do trabalho, sob risco de transferir ao trabalhador a responsabilidade por riscos produzidos pela própria organização. Qualquer ferramenta utilizada deve ter qualidade e efetividade verificadas previamente.

Diretrizes de execução: treinamentos conduzidos por instrutores competentes, preferencialmente dentro da jornada remunerada de trabalho, com atualização periódica e avaliação de aplicação prática ao final de cada ciclo.

PÚBLICO	CONTEÚDO MÍNIMO	PERIODICIDADE
Alta liderança e gestores	Reconhecimento de sinais, escuta ativa, encaminhamento, prevenção de assédio e segurança psicológica.	Anual, com reforço na integração de novos gestores
Trabalhadores em geral	Literacia em saúde mental, redução de estigma, canais de apoio disponíveis.	Anual
CIPA e representantes	Identificação de riscos psicossociais no mapa de riscos e nas inspeções.	Conforme mandato da comissão

09 Diversidade, inclusão e proteção dos grupos vulnerabilizados

Os riscos psicossociais e os recursos de proteção não são distribuídos de forma homogênea entre as pessoas trabalhadoras. A avaliação de riscos e as políticas de saúde mental devem considerar, quando pertinente, gênero, raça, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, função, vínculo contratual, renda, território, acesso à saúde e responsabilidades de cuidado.

Merecem atenção específica, entre outros, trabalhadores terceirizados, temporários e recém-admitidos, pessoas com deficiência, grupos étnico-raciais historicamente marginalizados, mulheres em posições de dupla jornada e cuidado, e pessoas LGBTQIA+, que podem ter maior dificuldade para relatar situações críticas e exigem mecanismos específicos de proteção e escuta.

- Assegurar que políticas e canais de saúde mental sejam acessíveis, acolhedores e sensíveis às diferentes experiências das pessoas trabalhadoras.

- Adotar protocolos inclusivos e capacitar as equipes de saúde e RH para lidar com a diversidade da força de trabalho.
-
- Garantir privacidade e confidencialidade reforçadas para grupos com maior exposição a discriminação ou retaliação.
-
- Monitorar, nos indicadores do Comitê, eventuais disparidades de acesso, afastamento ou adoecimento entre diferentes grupos.
-

10 Ciclo de gestão de riscos psicossociais

A gestão dos riscos psicossociais segue um ciclo contínuo de sete etapas, alinhado à mesma arquitetura utilizada para os demais riscos ocupacionais da organização:

- 01 Avaliação inicial** — compreender por que a organização precisa agir.
-
- 02 Identificação dos riscos** — localizar perigos, grupos expostos e contextos de trabalho.
-
- 03 Avaliação dos riscos** — estimar probabilidade, gravidade, exposição e prioridade.
-
- 04 Prevenção primária e ambientes saudáveis** — atuar sobre organização, processos, liderança e cultura.
-
- 05 Medidas de controle e mitigação** — reduzir riscos que não puderam ser eliminados.
-
- 06 Apoio e resposta** — oferecer intervenções secundárias e terciárias às pessoas afetadas.
-
- 07 Monitoramento e melhoria contínua** — avaliar resultados, corrigir ações e reiniciar o ciclo.
-

11 Prevenção terciária, cuidado e retorno ao trabalho

Destina-se às pessoas que já apresentam adoecimento, incapacidade ou afastamento, com foco em tratamento, encaminhamento especializado, acompanhamento ocupacional, prevenção de recaídas e preservação da confidencialidade. As diretrizes da OMS e da OIT recomendam três intervenções complementares:

Adaptações razoáveis no trabalho

Ajustam o ambiente às capacidades, necessidades e preferências do trabalhador: horários flexíveis, tempo adicional para conclusão de tarefas, afastamento remunerado para cuidados de saúde mental, acesso a espaços privados, reuniões de apoio regulares com a liderança ou redesenho de função quando o contato com público for excessivamente estressante.

Programas de retorno ao trabalho

Permitem que o trabalhador retorne e permaneça no emprego após afastamento associado a condições de saúde mental, combinando adaptações razoáveis ou reingresso gradual com acompanhamento clínico continuado.

Emprego apoiado

Destinado a pessoas com condições de saúde mental mais graves, combina inserção rápida no trabalho remunerado com suporte contínuo de saúde mental e vocacional, podendo incluir treinamento de habilidades sociais ou terapia cognitivo-comportamental como complemento.

Essas três intervenções exigem coordenação multissetorial entre serviços de saúde, RH, liderança direta, trabalhador e, quando existirem, seus representantes e familiares. As decisões sobre quais medidas adotar devem considerar as preferências do próprio trabalhador e ser revisadas periodicamente, pois as necessidades de suporte variam ao longo do tempo.

12 Gestão de crises e situações sensíveis

A organização deve manter protocolos claros para a condução de situações críticas, definindo previamente quem acolhe, quem avalia, quem encaminha, como se preserva a confidencialidade e como se apoia a equipe afetada. Aplica-se, entre outras, às seguintes situações:

- crises de ansiedade, pânico ou descompensação emocional;
- comportamento de risco ou ideação de autolesão;
- situações de violência, assédio moral ou sexual;
- eventos traumáticos, acidentes graves ou morte de trabalhadores;
- crises coletivas decorrentes de reestruturações ou incidentes relevantes.

Os fluxos de encaminhamento devem ser formalizados em procedimento específico, elaborado em conjunto com a área de saúde ocupacional, o SESMT e, quando aplicável, apoio técnico especializado externo, preservando sempre a confidencialidade e a dignidade das pessoas envolvidas.

13 Frentes complementares: transformações do mundo do trabalho

As transformações tecnológicas, organizacionais e contratuais do mundo do trabalho criam riscos psicossociais próprios, que precisam ser geridos de forma explícita pela governança – e não apenas como efeitos colaterais de decisões de negócio.

13.1 • Gestão de mudanças organizacionais

Toda mudança relevante (reestruturações, fusões, mudanças de processos, tecnologia ou equipe) deve ter seus impactos psicossociais avaliados previamente. Recomenda-se comunicar os motivos, envolver as pessoas afetadas, permitir participação, informar cronogramas, esclarecer impactos sobre funções e equipes, oferecer treinamento e suporte, e acompanhar os efeitos para corrigir consequências não previstas.

13.2 • Trabalho remoto e direito à desconexão

As políticas de teletrabalho devem equilibrar flexibilidade, autonomia, eficiência e proteção à saúde mental, contemplando limites de jornada, direito à desconexão, regras para comunicação fora do expediente, redução de reuniões desnecessárias, ergonomia, pausas, manutenção de vínculos sociais e acompanhamento do isolamento, com atenção às desigualdades de gênero na divisão de tarefas domésticas e de cuidado.

13.3 • Uso ético da tecnologia e da inteligência artificial

A adoção de tecnologias e de sistemas de inteligência artificial deve considerar o impacto sobre empregos e competências, o risco de intensificação do trabalho e de vigilância excessiva, a transparência dos algoritmos, a proteção de dados, a possibilidade de contestação de decisões automatizadas e os vieses discriminatórios. A inteligência artificial não deve substituir o cuidado psicológico ou psiquiátrico, devendo seu uso ser acompanhado de critérios éticos e supervisão humana.

13.4 • Proteção nas diferentes formas de contratação

A gestão de riscos psicossociais deve abranger empregados diretos, terceirizados, temporários, autônomos e trabalhadores mediados por plataformas, considerando riscos específicos como insegurança de renda, falta de proteção social, isolamento, controle algorítmico, ausência de representação e menor poder para relatar abusos, garantindo acesso equivalente aos canais de escuta e às medidas de proteção previstas neste procedimento.

13.5 • Transição justa

Mudanças tecnológicas, climáticas e produtivas relevantes para o negócio devem ser acompanhadas de diálogo, preparação das pessoas, capacitação, requalificação, proteção social e acesso equitativo a oportunidades, prevenindo desligamentos traumáticos e apoiando as equipes e comunidades afetadas pela transformação.

14 Fatores transversais de governança

Sete fatores transversais sustentam a implementação de todas as estratégias anteriores e devem constar do relatório periódico ao Conselho:

FATOR	O QUE SIGNIFICA	RESPONSÁVEL PRINCIPAL
Liderança	Comprometimento formal e visível da alta gestão com o tema.	Conselho e Diretoria
Investimento	Recursos financeiros e humanos alocados às ações previstas.	Diretoria e RH
Direitos	Políticas de não discriminação, confidencialidade e proteção contra retaliação.	Jurídico e RH
Integração	Inclusão da saúde mental no sistema de gestão de riscos e no PGR/GRO.	SESMT / SST
Participação	Escuta e consulta a trabalhadores e seus representantes.	RH e Comitê
Evidências	Uso de dados e avaliações periódicas para orientar decisões.	Comitê
Conformidade	Monitoramento do cumprimento de leis, normas e políticas internas.	Compliance e Jurídico

15 Indicadores e prestação de contas ao Conselho

Os indicadores a seguir compõem o painel mínimo de acompanhamento, consolidado pelo Comitê e reportado ao Conselho com periodicidade semestral, sem prejuízo de relatos extraordinários em caso de eventos críticos:

INDICADOR	FONTE DE DADOS	PERIODICIDADE	REPORTADO A
Absenteísmo relacionado à saúde mental	RH / Folha de pagamento	Mensal	Comitê
Afastamentos por transtornos mentais (CID F)	Medicina Ocupacional	Trimestral	Comitê e Diretoria
Rotatividade (turnover)	RH	Trimestral	Comitê
Denúncias e acionamentos de canais de escuta	Canal de ética / Ouvidoria	Mensal	Comitê e Jurídico
Índice de segurança psicológica	Pesquisa de clima / avaliação psicossocial	Anual	Conselho
Adesão a treinamentos de lideranças e trabalhadores	RH / T&D	Semestral	Comitê
Reincidência de afastamento (retorno ao trabalho)	Medicina Ocupacional	Semestral	Comitê e Diretoria
Percentual de riscos psicossociais mitigados no PGR	SESMT / SST	Semestral	Conselho
Disparidades de acesso e afastamento entre grupos	RH / Comitê	Anual	Conselho

16 Cronograma de implementação

FASE	OBJETIVO	PRAZO SUGERIDO
Fase 1 — Diagnóstico e governança	Diagnóstico psicossocial inicial, constituição do Comitê e aprovação do procedimento pelo Conselho.	0 a 3 meses
Fase 2 — Estruturação e capacitação	Definição de políticas, fluxos de crise, protocolos de retorno ao trabalho e capacitação de lideranças e trabalhadores.	3 a 6 meses
Fase 3 — Operação e monitoramento	Execução das ações preventivas, protetivas e de apoio, com acompanhamento dos indicadores.	6 a 12 meses
Fase 4 — Revisão e melhoria contínua	Avaliação anual de resultados, atualização do PGR e revisão do procedimento.	Ciclo anual

17 Revisão e melhoria contínua

Este procedimento deve ser revisado anualmente pelo Comitê de Saúde Mental e Riscos Psicossociais e submetido à aprovação do Conselho de Administração. Revisões extraordinárias devem ocorrer diante de mudanças relevantes na legislação, resultados de auditorias, incidentes críticos ou alterações significativas na estrutura organizacional.

18 Referências

Movimento Mente em Foco. *Saúde Mental e Futuro do Trabalho*.

Organização Mundial da Saúde e Organização Internacional do Trabalho. *Mental health at work: policy brief*. Genebra, 2022.

Organização Mundial da Saúde. *WHO guidelines on mental health at work*. Genebra, 2022.

International Organization for Standardization. *ISO 45003:2021 — Occupational health and safety management: psychological health and safety at work*.

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). *Princípios básicos de governança corporativa*.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1)*.

ANEXOS

Modelos de apoio à implementação

Os anexos a seguir devem ser adaptados à realidade, ao porte e à estrutura de governança de cada organização antes de sua utilização.

A Termo de constituição do Comitê

O presente Termo institui o Comitê de Saúde Mental e Riscos Psicossociais de **[Nome da Empresa]**, com a finalidade de coordenar, monitorar e reportar as ações de prevenção, proteção, promoção e apoio à saúde mental no ambiente de trabalho, em conformidade com o Procedimento de Governança em Saúde Mental Corporativa aprovado pelo Conselho de Administração.

A.1 • Objetivo

Coordenar a implementação deste procedimento, consolidar diagnósticos e indicadores, priorizar ações preventivas, protetivas e de apoio, e reportar periodicamente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

A.2 • Composição

-
- Representante da Diretoria Executiva (patrocinador do Comitê).
-
- Representante de Recursos Humanos (coordenação do Comitê).
-
- Representante do SESMT / Saúde e Segurança do Trabalho.
-
- Representante Jurídico.
-
- Representante de Compliance.
-
- Representante da CIPA, quando existente.
-
- Representante dos trabalhadores, eleito ou indicado conforme prática da organização.
-

A.3 • Mandato e atribuições

-
- Consolidar os diagnósticos de riscos psicossociais e os indicadores de saúde mental da organização.
-
- Priorizar e acompanhar a execução das ações previstas no ciclo de gestão de riscos psicossociais.
-
- Revisar e atualizar os protocolos de gestão de crises e situações sensíveis.
-
- Propor à Diretoria e ao Conselho ajustes e atualizações a este procedimento.
-
- Reportar semestralmente ao Conselho de Administração, sem prejuízo de relatos extraordinários em caso de eventos críticos.
-
- Zelar pela confidencialidade das informações individuais tratadas no âmbito de suas atribuições.
-

A.4 • Funcionamento

-
- Reuniões ordinárias trimestrais; extraordinárias mediante convocação de qualquer membro em caso de evento crítico.
-
- Quórum mínimo de metade dos membros para deliberação.
-
- Lavratura de ata em cada reunião e envio de relatório consolidado ao Conselho a cada semestre.
-

A.5 • Vigência e revisão

Este Termo entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e permanece válido até revisão ou substituição, observado o ciclo de revisão anual previsto no Procedimento de Governança em Saúde Mental Corporativa.

A.6 • Aprovação

NOME	CARGO	ASSINATURA	DATA

B Fluxo de gestão de crises e situações sensíveis

Representação, em nível gerencial, do fluxo mínimo recomendado na Seção 12 deste procedimento.

01

Identificação do evento

Liderança, colega, canal de escuta ou serviço de saúde identifica a situação crítica.

02

Acolhimento imediato

Garantir segurança da pessoa, privacidade e escuta sem julgamento. Nenhum diagnóstico é feito nesta etapa.

03

Acionamento técnico

Saúde ocupacional, SESMT ou apoio especializado externo avalia a gravidade e define a conduta.

04

Encaminhamento

Rede de saúde, serviço de emergência, jurídico ou canal de ética, conforme a natureza do evento.

05

Apoio à equipe afetada

Comunicação responsável, suporte coletivo e cuidado com o efeito do evento sobre o grupo.

06

Registro e acompanhamento

Registro confidencial, acompanhamento do caso e reporte agregado ao Comitê.

07

Revisão de causas organizacionais

Analisar fatores de trabalho envolvidos e alimentar o ciclo de gestão de riscos (Seção 10).

Os fluxos detalhados de encaminhamento clínico e de rede de saúde devem ser formalizados junto à área de saúde ocupacional e ao SESMT, preservando a confidencialidade e a dignidade das pessoas envolvidas em todas as etapas.

c Modelo de painel de indicadores para o Conselho

Painel-resumo para apresentação semestral ao Conselho de Administração, com os indicadores prioritários definidos na Seção 15. Os campos devem ser preenchidos pelo Comitê a cada ciclo de reporte.

INDICADOR	VALOR ATUAL	META	TENDÊNCIA
Absenteísmo relacionado à saúde mental	[]	[]	↑ / ↓ / →
Afastamentos por transtornos mentais (CID F)	[]	[]	↑ / ↓ / →
Rotatividade (turnover)	[]	[]	↑ / ↓ / →
Índice de segurança psicológica	[]	[]	↑ / ↓ / →
Adesão a treinamentos de lideranças e trabalhadores	[]	[]	↑ / ↓ / →
Percentual de riscos psicossociais mitigados no PGR	[]	[]	↑ / ↓ / →

Legenda de tendência: ↑ aumento em relação ao ciclo anterior | ↓ redução em relação ao ciclo anterior | → estável.

ESCUTARIS

Ciência que escuta, soluções que transformam. Diagnóstico psicossocial, mentoria de liderança e consultoria em NR-1.

